



Nur zur dienstlichen Verwendung

Dieser Vermerk verliert seine Gültigkeit mit der Veröffentlichung des Protokolls gemäß § 73 GOBT, spätestens jedoch nach Ablauf der jeweils nachfolgenden Wahlperiode.

Kurzprotokoll der 2. Sitzung

Ausschuss für Gesundheit

Berlin, den 4. Juni 2025, 09:30 Uhr
als Kombination aus Präsenzsitzung
(Paul-Löbe-Haus, Saal E 300) und
Zoom-Meeting

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 5

Bericht der Bundesregierung zum aktuellen Stand
des Pandemieabkommens

Selbstbefassung S-21(14)1

Tagesordnungspunkt 2

Seite 8

Bericht der Bundesregierung zum jüngsten Schieds-
spruch zum Vertrag über die Hebammenhilfe mit
dem Schwerpunkt zur Situation der Beleghebam-
men

Selbstbefassung S-21(14)2



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 3

Seite 11

Bericht der Bundesregierung zum Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und 13 weitere Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Richtlinie zur Anerkennung der Berufsqualifikationen von in Rumänien ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpflegern

Selbstbefassung S-21(14)3

Tagesordnungspunkt 4

Seite 14

Bericht der Bundesregierung über die aktuelle Finanzsituation der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Sozialen Pflegeversicherung sowie über die geplanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzierung

Selbstbefassung S-21(14)4

Tagesordnungspunkt 5

Seite 17

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Deutscher Fortschrittsbericht 2025

BT-Drucksache 21/62

Federführend:
Haushaltsausschuss

Mitberatend:
Finanzausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Gesundheit
Verkehrsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Tagesordnungspunkt 6

Seite 5

Verschiedenes

Antrag auf Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Mitglieder des Ausschusses

Fraktionen	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Beek, Sascha van Borchardt, Simone Hiller, Dr. Matthias Janssen, Anne Müller, Axel Pauls, Dr. Thomas Pilsinger, Dr. Stephan Schmidt, Sebastian Seitz, Nora Streeck, Dr. Hendrik Theiss, Dr. Hans Weiss, Dr. Maria-Lena Zeulner, Emmi	Albani, Stephan Demuth, Ellen Ehm, Lars Grasse, Adrian Knoerig, Axel Ludwig, Dr. Saskia Müller, Sepp Reddig, Pascal Rupprecht, Albert Staffler, Katrin Stegemann, Albert Timmermann-Fechter, Astrid Walch, Siegfried
AfD	Baum, Dr. Christina Bloch, Joachim Dietz, Thomas Ebenberger, Tobias Hess, Nicole Schießl, Carina Sichert, Martin Weiss, Claudia Ziegler, Kay-Uwe	Bessin, Birgit Birghan, Dr. Christoph Bollmann, Gereon Fetsch, Thomas Giersch, Alexis L. Kempf, Martina Möller, Stefan Przygodda, Kerstin Schmidt, Dr. Paul
SPD	Machalet, Dr. Tanja Mieves, Matthias David Moll, Claudia Pantazis, Dr. Christos Schwartz, Stefan Seitzl, Dr. Lina Yüksel, Serdar	Ahmetovic, Adis Dittmar, Sabine Glöckner, Angelika Kersten, Dr. Franziska Peick, Jens Schmidt, Dagmar
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dahmen, Dr. Janosch Fischer, Simone Heitmann, Linda Kappert-Gonther, Dr. Kirsten Wagner, Johannes	Grau, Dr. Armin Nick, Dr. Ophelia Piechotta, Dr. Paula Rietenberg, Sylvia
Die Linke	Gürpinar, Ates Merendino, Stella Schötz, Evelyn Stange, Julia-Christina	Arndt, Dr. Michael Brückner, Maik Fey, Katrin Gebel, Kathrin



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beginn der Sitzung: 9:31 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die **Vorsitzende, Abg. Dr. Tanja Machalet**, eröffnet die Sitzung und begrüßt den Parlamentarischen Staatssekretär Tino Sorge. Sie gratuliert Abg. Stefan Schwartze (SPD) zur Ernennung zum Patientenbeauftragten, Dr. Hendrik Streeck (CDU/CSU) zur Ernennung zum Drogen- und Suchtbeauftragten sowie Katrin Staffler (CDU/CSU) zur Ernennung zur Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Zur Tagesordnung gibt sie an, Tagesordnungspunkt 4 sei neu aufgesetzt worden. Tagesordnungspunkt 6 werde vorgezogen und umfasse die Abstimmung über den Antrag auf Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen. Sie stellt die Tagesordnung fest.

Tagesordnungspunkt 6

Verschiedenes

Antrag auf Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen

Die **Vorsitzende** erklärt, mangels Einigung in der gestrigen Obleute-Besprechung sei eine Abstimmung im Ausschuss erforderlich.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) führt aus, seine Fraktion sei der Ansicht, die Menschen sollten mitbekommen, worüber in den Ausschusssitzungen debattiert werde, da der Ausschuss nichts zu verbergen habe. Es bestehe stets die Möglichkeit, im Einzelfall von der Regelung abzuweichen und die Öffentlichkeit von Tagesordnungspunkten auszuschließen.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) widerspricht, wenn es um die Fachlichkeit gehe, sei die Nichtöffentlichkeit Grundvoraussetzung.

Der Ausschuss lehnt den Antrag auf Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke ab.

Tagesordnungspunkt 1

Bericht der Bundesregierung zum aktuellen Stand des Pandemieabkommens

Selbstbefassung S-21(14)1

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für

Gesundheit (BMG)) gibt an, in der vergangenen Legislaturperiode seien bereits erhebliche Diskussionen über das Pandemieabkommen geführt worden. Der Konsens über das Pandemieabkommen sei ein Erfolg und der Verhandlungstext sei mit einer breiten Mehrheit angenommen worden. Dadurch werde ein wichtiges Signal im Sinne der Solidarität gesendet. Inhaltlich gehe es in dem Abkommen nicht darum, in nationale Kompetenzen einzugreifen, sondern vielmehr um die „Lessons Learned“. Es würden Grundlagen für künftige Pandemien festgelegt, damit diese besser verhindert und abgemildert werden könnten und schneller reagiert werden könne, da sich bei der COVID-19-Pandemie Probleme bei der internationalen Abstimmung gezeigt hätten. Dementsprechend gehe es in dem Abkommen um Punkte wie die Gesundheitssystemstärkung und die Interoperabilität von Daten, da bei den digitalen Möglichkeiten und dem Informationsaustausch noch Optimierungsbedarf bestehe. Ebenso würden die Stärkung der Gesundheits- und Pflegefachkräfte sowie die Errichtung eines weltweiten Lieferketten- und Logistiknetzwerkes aufgegriffen. Insgesamt sei sehr positiv, dass nunmehr der One Health-Ansatz verankert worden sei. Es sei ausdrücklich darauf geachtet worden, dass keine völkerrechtlichen Bindungen aus dem Abkommen entstünden und diesem lediglich appellativer Charakter zukomme.

Abg. **Sascha van Beek** (CDU/CSU) äußert, der Abschluss eines derartigen internationalen Abkommens auf WHO-Ebene sei sehr erfreulich und fortschrittlich. Es müsse herausgehoben werden, dass durch das Abkommen nicht in die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten eingegriffen werde. Die entsprechende Gesetzgebung und die Entscheidung über die Maßnahmen würden ausschließlich von den Mitgliedstaaten selbst entschieden. Insgesamt sei bei einer Pandemie schnelles Handeln erforderlich. Er erkundigt sich nach dem groben Zeitplan für die nun umzusetzenden Maßnahmen.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, im Rahmen des Pandemieabkommens gehe es auch um die Verhandlung eines weiteren Annexes, in dem das sogenannte PABS-System (Pathogen Access and Benefit Sharing), ein Zugangs- und Vorteilsausgleichsmechanismus geregelt werde. Die Verhandlungen sollten innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, im Nachgang müsse die Ratifizierung in den Mitgliedstaaten erfolgen. Dies finde durch die gesetzgeberischen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Prozesse statt, sodass auch der Ausschuss involviert werde und Probleme und Bedenken kommuniziert und entsprechend berücksichtigt werden könnten.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) gibt an, es gebe sehr viel Kritik an dem Pandemieabkommen. Bis heute liege die geänderte Form nicht vor, dennoch habe Deutschland dem Abkommen zugestimmt. Sie fragt, warum das Abkommen nicht zunächst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es sei in der vergangenen Legislaturperiode häufig über das Thema diskutiert worden. Die Kommunikation der Mitgliedstaaten sei zwar optimierungsfähig, jedoch seien in diesem Fall die Dokumente im Zuge der Beratungen veröffentlicht worden. Man befinde sich noch im Diskussionsprozess. Wenn dieser auf internationaler Ebene abgeschlossen sei, beginne die Ratifizierung.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) sagt, Bundesministerin Nina Warken habe nach ihrer Teilnahme bei den Verhandlungen der WHO in Genf auf der Plattform X ein Zitat veröffentlicht, nach dem es durch das Abkommen nun verbindliche Regelungen zur Stärkung von Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion gebe. Sie möchte wissen, was unter den verbindlichen Regelungen zu verstehen sei und ob die Mitgliedstaaten noch eigene Entscheidungen treffen könnten.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, mit dem Abkommen würden den Nationalstaaten keineswegs Kompetenzen genommen und Umsetzungspflichten auferlegt. Die Mitgliedstaaten hätten sich vielmehr verpflichtet, gemeinsam im Hinblick auf künftige Pandemien bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Hinsichtlich der Umsetzung hätten sie ein gewisses Ermessen. Bei der Frage digitaler Anwendungen und Interoperabilität gehe es beispielsweise um die Verständigung auf einheitliche Standards, um den Informationsaustausch zu beschleunigen.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, ob laut aktuellem Vertrag der Generaldirektor der WHO die alleinige Befugnis habe, eine Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen auszurufen und, falls ja, wie dies beurteilt werde.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, im Rahmen der Diskussionen

müsse sich in der internationalen Gemeinschaft darauf verständigt werden, unter welchen Voraussetzungen eine Pandemie vorliege. Es müsse dann eine Institution geben, die dies formal nach außen trage. Dies bedeute jedoch nicht, dass diese Institution oder die einzelne Person über die Köpfe der Nationalstaaten hinweg die Entscheidungen treffe.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) hakt nach, ob der Generaldirektor die alleinige Befugnis habe, eine Pandemie auszurufen.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) äußert, er habe die Befugnis, nach einem Rückkoppelungsprozess mit den Nationalstaaten die einheitlich getroffenen Regelungen und Vereinbarungen zu kommunizieren. Er könne dabei nicht entgegen der Ansicht der Mitgliedstaaten Maßnahmen oder Entscheidungen verkünden.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, was unter dem in Artikel 12 des Pandemieabkommens verankerten System des Pathogen-Sharings verstanden werde und ob die Staaten verpflichtet würden, gefährliche Erreger weltweit zu teilen. Zudem möchte sie wissen, wie dabei die Biosicherheit beim globalen Transfer gewährleistet werde.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) sagt, im Falle von Pandemien sei es wichtig, sich über Probleme, Voraussetzungen und Erreger möglichst zeitnah auszutauschen. Durch dieses Verfahren werde ermöglicht, entsprechende Informationen über pathogene Erreger zu teilen und diese international zu bekämpfen.

Abg. **Serdar Yüksel** (SPD) stellt klar, dass beim Durchlesen des vierten Teils des Vertrages hätte festgestellt werden können, dass der WHO oder dem Generaldirektor keinerlei Befugnis zum Eingreifen in die nationale Gesetzgebung oder zum Erlass bestimmter Maßnahmen zukämen. Er fragt, wie die Bundesregierung sicherstelle, dass das Rahmenwerk des Pandemieabkommens in konkrete Handlungen umgesetzt werde und wie das Abkommen im Sinne der Transparenz und Akzeptanz mit der Bevölkerung kommuniziert werden solle, um Verschwörungstheorien vorzubeugen. Außerdem erkundigt er sich, wie der Bundestag an der Ausgestaltung des PABS beteiligt werde.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) stimmt zu, dass die Kommunikation viel offensiver stattfinden müsse. Er habe bereits in



Nur zur dienstlichen Verwendung

der letzten Legislaturperiode bedauert, dass man sich bei der COVID-19-Pandemie politisch defensiv verhalten habe, obwohl viele Dinge gut und richtig gemacht worden seien. Im Rahmen der Verhandlungen des Abkommens gehe es auch darum, Befindlichkeiten der Nationalstaaten ernst zu nehmen. Einzelne Mitgliedstaaten hätten bereits Gesprächsbedarf angemeldet, sodass letztlich Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse. Insofern müsse, wie BMn Nina Warken bereits geäußert habe, Deutschland als einer der größten Mitgliedstaaten vorangehen und mit positiven Argumenten überzeugen. Insgesamt müsse man selbstbewusst sagen, dass das Abkommen – auch im Hinblick auf den One Health-Ansatz – ein Erfolg sei.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont die Wichtigkeit des Pandemieabkommens und den darin enthaltenen One Health-Ansatz. Im Abkommen werde eine globale Verbindlichkeit bezüglich des transparenten Austausches von Wissen über Pathogenität und Beschaffenheit von Krankheitserregern festgelegt. Es bestünden nun Sorgen, wie sich diese Verbindlichkeit in Anbetracht dessen darstelle, dass autokratische Staaten wie China und Russland, aber auch die USA und die Slowakei durch Falschbehauptungen seitens der Regierungen gegen das Pandemieabkommen agiert hätten. Sie fragt, wie das bewertet werde und wie die Transparenz unter diesen Bedingungen hergestellt werden könne.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dies werde nur durch ständige Überzeugungsarbeit funktionieren. Dass sich Polen und die Slowakei atypisch verhalten hätten, dürfe unter anderem aufgrund von Präsidentschaftswahlen und weiteren Faktoren nicht zu hoch bewertet werden. Langfristig müssten die Mitgliedstaaten von den Vorteilen des Abkommens überzeugt werden. Bei den autokratischen Staaten sei es zwar schwierig einzuschätzen, ob sie rational handelten, dennoch müssten Versuche, zu einheitlichen Regelungen zu kommen, unternommen werden. Auch deswegen sei es wichtig, dass Deutschland mit einer gewissen Gelassenheit voranschreite und in kontroversen Debatten mit besseren Argumenten überzeuge.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beteuert, das Abkommen sei ein großer Schritt nach vorne. Die angesprochenen Probleme müssten aufgrund der potenziellen Nachteile

dennoch beachtet werden. Die UN Women habe die COVID-19-Pandemie auch als Krise der Frauen bezeichnet, da beispielsweise viel mehr Frauen in Pflegeberufen arbeiteten und bis zu dreimal mehr Sorgearbeit leisteten, sodass sie dem Virus besonders ausgesetzt gewesen seien und es besondere Vulnerabilitäten gegeben habe. Sie fragt nach einer Bewertung des Pandemieabkommens mit Blick auf die Gender-Gerechtigkeit.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, im Abkommen sei auf Gender Equality hingewiesen worden. In der Diskussion werde es häufig als Nischenthema behandelt, er sei jedoch der Ansicht, dass es stets Verbesserungsbedarf auch im Hinblick auf die Unterschiede bei den Geschlechtern gebe. Der Punkt, dass Frauen von der Pandemie überdurchschnittlich stark betroffen gewesen seien, lasse sich auch auf viele andere Lebensbereiche übertragen und es entspreche der Realität, dass Frauen auf vielen Gebieten ganz anderen Belastungen ausgesetzt seien. Dies müsse zukünftig noch stärker berücksichtigt werden.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sagt, Mental Health-Aspekte würden nun richtigerweise mehr in den Fokus gerückt. Sie möchte wissen, wie das Pandemieabkommen in dieser Hinsicht bewertet werde und ob ein ausreichend starker Fokus auf die Auswirkungen auf die seelische Gesundheit gelegt werde.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, es gebe immer Optimierungs- und Verbesserungsbedarf. Dies gelte insbesondere bei Mental Health, da dies alle Bereiche des Gesundheitswesens betreffe. Dazu werde man sich auch im Ausschuss in den nächsten Monaten und Jahren ausgiebig austauschen.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) interessiert vor allem die Position Deutschlands in den Verhandlungen. Beispielsweise sei die Unterstützung des globalen Südens auch ein Aspekt gewesen, da die reicheren Länder im Zuge der Pandemie die Impfstoffe gekauft hätten und dadurch der globale Süden vernachlässigt worden sei. 10 Prozent der Impfstoffproduktion müssten ärmeren Ländern gespendet und weitere 10 Prozent zu reduzierten Preisen verkauft werden. Er fragt, wie sich Deutschland zu diesem Punkt verhalten habe.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bedauert, die schnellere Beschaffung



Nur zur dienstlichen Verwendung

von Impfstoffen und Schutzausrüstung durch die Stärkeren und Schnelleren sei ein Umstand, der nicht nur in der Pandemie zutage trete. Allerdings seien auch mit Fortschreiten der Pandemie und mit der Verbesserung der Impfstoffproduktion erhebliche Impfstofflieferungen in den globalen Süden erfolgt. Teilweise sei aus manchen Ländern die Nachfrage mangels ausreichender Aufklärung und Überzeugungsarbeit nicht so hoch gewesen, wie sie hätte gewesen sein können. Auch dies müsse in Zukunft genauer betrachtet werden. Intention des Abkommens sei die gemeinsame Lösung und Bewältigung von Pandemien im Sinne des One Health-Ansatzes, sodass auch die Impfstofflieferungen in schwächere Länder angegangen werden müsse.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) hakt nach, ob die 10 Prozent der Impfstoffproduktion für ärmere Länder auf die Zustimmung Deutschlands gestoßen sei oder ob eine höhere oder niedrigere Quote angestrebt gewesen sei.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, es habe sich diesbezüglich um komplexe Diskussionen gehandelt. Perspektivisch sei es wichtig festzustellen, wie man die Länder besser unterstützen könne. Bei der COVID-19-Pandemie habe sich etwa auch bei der Frage, wie schnell man Impfstoffproduktionen in den Ländern hochziehen und die erforderliche Infrastruktur schaffen könne, gezeigt, dass die Vorgänge sehr komplex seien und optimiert werden müssten.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) sagt, die fehlende Freigabe von Patenten sei damals ein Problem gewesen und erkundigt sich, ob das Abkommen diesbezüglich Möglichkeiten zur Freigabe oder für einen einfacheren Zugang enthalte.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) stellt klar, die Aufhebung des Patentschutzes sei nicht so einfach. Allein diese reiche nicht aus, da im globalen Süden die Infrastrukturkapazitäten fehlten und die Erhöhung der Impfstoffproduktion ein komplexes Verfahren mit einer Vielzahl von Einzelschritten sei. Zudem sei nicht zu vernachlässigen, dass die forschenden Unternehmen auch ein Interesse daran hätten, dass sich ihre teure Forschung amortisiere. Die Aufhebung des Patentschutzes stelle ein erhebliches Risiko für diese Unternehmen und ihre Investitionen dar.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) merkt an, die finanzielle Lage der Unternehmen, die die Impfstoffe entwickelt hätten, sei nicht gerade schlecht. Hinsichtlich des PABS, das auch den Umgang mit exklusivem Wissen betreffe und noch nicht ausverhandelt worden sei, möchte er wissen, ob ein Zeitplan vorliege und welche Einzelheiten noch strittig seien.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) legt dar, das Gesamtabkommen werde erst mit einem Abschluss über das PABS ratifiziert. Nach dem Zeitplan des BMG werde dies idealerweise im nächsten Jahr sein, allerdings sei dies auch vom Diskussionsprozess mit den weiteren Mitgliedstaaten abhängig. Die Frage, wie Unternehmen perspektivisch stärker zu altruistischem Handeln animiert werden könnten, sei grundsätzlicher Natur. Er stellt klar, dass mit Fortschreiten der Pandemie viele Unternehmen bereits uneigennützig gehandelt hätten.

Tagesordnungspunkt 2

Bericht der Bundesregierung zum jüngsten Schiedsspruch zum Vertrag über die Hebammenhilfe mit dem Schwerpunkt zur Situation der Beleghebammen

Selbstbefassung S-21(14)2

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, es handele sich um ein sehr wichtiges und emotionales Thema. In dem Schiedsspruch nach § 134a SGB V gehe es darum, das Nähere zur Versorgung mit Hebammenhilfe durch freiberuflich tätige Hebammen zwischen dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen Berufsverbänden der Hebammen zu regeln. Das BMG sei dabei nicht unmittelbar beteiligt, da dies eine Frage für die Selbstverwaltung sei und in erster Linie untereinander verhandelt werden müsse. Es habe einen Kompromissvorschlag gegeben, dem der Deutsche Hebammenverband nicht zugestimmt, sondern die Schiedsstelle angerufen habe. Es werde sich nun zeigen, ob gegen den Schiedsspruch geklagt werde. Letztendlich gehe es um die Vergütungsregelung für Beleghebammen. Laut dem Deutschen Hebammenverband könne es dabei zu einer Vergütungsverschlechterung kommen, andere Verbände sähen dies anders. In der Sache gehe es um die stärkere Vergütung der Eins-zu-eins-Betreuung. Das BMG habe nur begrenzt Einfluss und lediglich



Nur zur dienstlichen Verwendung

die Rechtsaufsicht, teile jedoch den Ansatz, dass die Versorgung von Gebärenden und Müttern durch eine Eins-zu-eins-Betreuung durch Hebammen weiter gefördert werden solle. Es sei allerdings zunächst Aufgabe der Selbstverwaltung, sich entsprechend zu verständigen.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) betont die Wichtigkeit des Themas Geburtshilfe, über das auch in der Vergangenheit im Ausschuss viel diskutiert worden sei. Die Tätigkeit der Hebammen sei verantwortungsvoll und erfordere eine hohe Professionalität. Es sei bereits vieles zur Stärkung des Berufs unternommen worden, wie beispielsweise die Akademisierung. Der Bericht zeige, dass die Thematik auch der Bundesministerin ein wichtiges Anliegen sei. Derzeit sei der Schiedsspruch noch nicht an die Hebammen übermittelt worden. Sie möchte daher wissen, ob das BMG noch Einwirkungsmöglichkeiten habe. So sei in Bayern beispielsweise ein Dringlichkeitsantrag eingebracht worden, um die Übermittlung des Schiedsspruchs zu beschleunigen und um schneller eine Klagemöglichkeit prüfen zu können. Außerdem erkundigt sie sich nach möglichen Praxischecks. Diese seien im Koalitionsvertrag thematisiert worden. Es müsse verhindert werden, dass in der ohnehin angespannten Versorgungssituation ganze Teams von Beleghebammen ihre Tätigkeit aufgeben würden.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) betont, die Selbstverwaltung müsse die nachhaltige Hebammenversorgung sicherstellen und sich darüber mit den Hebammen verständigen. Die Politik müsse dabei vorsichtig sein und dürfe nicht eingreifen, da dies eine Präcedenzwirkung nach sich ziehen würde. Das BMG habe hinsichtlich des Schiedsspruchs lediglich die Rechtsaufsicht und dürfe keine inhaltliche Prüfung vornehmen. Es gehe nunmehr darum, gegebenenfalls zwischen den Akteuren zu vermitteln, um das gemeinsame Ziel der bestmöglichen Hebammenversorgung zu erreichen. Außerdem gebe es eine Evaluationsvorschrift und das BMG habe bereits explizit dazu aufgefordert, mögliche Verwerfungen früher anzuzeigen. Er gehe davon aus, dass die Akteure sich nochmals zusammensetzten.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) stellt die Frage, ob die Schiedsstelle bereits zuvor bestanden habe oder ob sie konkret für diesen Fall zusammengesetzt worden sei. Laut Statement des Deutschen Hebammenverbandes sei dieser vernachlässigt worden und

man bekomme das Gefühl, die Schiedsstelle habe sich auf die Seite des GKV-Spitzenverbandes gestellt. Er fragt, wie das BMG dies sehe und ob der Schiedsspruch kritisch zu betrachten sei.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, die Schiedsstelle sei gemäß § 134a SGB V für dieses Verfahren eingesetzt worden. Das BMG habe, wie bereits erwähnt, lediglich die Rechtsaufsicht, sodass die Schiedsstelle in ihrem Schiedsspruch frei sei. Den betroffenen Akteuren stehe es sodann frei, Klage zu erheben. Ob dies eintreten werde oder doch eine Einigung erzielt werden könne, sei nun abzuwarten. Inwiefern die Schiedsstelle sich auf die Seite des GKV-Spitzenverbandes geschlagen habe, vermöge er nicht zu beurteilen. Es gebe unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Vergütung sich verschlechtern werde oder gleich bleibe. Daher sei auch die Evaluationsregelung vorgesehen. Das BMG habe darauf hingewiesen, dass im Falle möglicher Probleme schneller evaluiert werden solle. Er gehe davon aus, dass der GKV-Spitzenverband dann auch handeln würde. Es sollten alle daran interessiert sein, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen und keine Verwerfungen zu erzeugen.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, wie das BMG den Schiedsspruch und die vorliegenden Zahlen bewerte und ob das BMG sich gegebenenfalls eine bessere Lösung für Beleghebammen vorstellen könne.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) weist darauf hin, dass der Kompromissvorschlag der Schiedsstelle ab dem 1. November 2025 gelten solle. Insofern sei noch unklar, ob gewisse Argumente, die wechselseitig vorgebracht worden seien, zuträfen. Es müsse nun schnell geprüft werden, ob es Verwerfungen gebe. Damit sollte nicht bis 2027 gewartet werden. Dann könne auch punktuell nachgesteuert werden. Er betont erneut, die Politik dürfe nicht jede Diskussion an sich ziehen und müsse die Selbstverwaltung selbst verhandeln lassen. Erst, wenn dies überhaupt nicht funktioniere, würde die Politik unter gewissen Umständen eingreifen.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) hebt die unersetzliche Rolle von Hebammen hervor, die in den vergangenen Jahren gestärkt worden sei und besser honoriert werde. Nun warnten die Beleghebammen eindringlich davor, dass die geburtshilfliche



Nur zur dienstlichen Verwendung

Versorgung ab Inkrafttreten des Hebammenhilfevertrages am 1. November 2025 in Gefahr sei. Die Politik müsse, wie PStS Tino Sorge bereits gesagt habe, einschreiten, sobald das System nicht mehr funktioniere und die flächendeckende geburtshilfliche Versorgung nicht mehr gewährleistet sei. Sie fragt, wie das BMG die unterschiedlichen Zahlen, die von den Akteuren vorgelegt worden seien, bewerte.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, das BMG nehme das Thema sehr ernst. Die Eins-zu-eins-Betreuung solle verbessert werden. Wie dies erzielt werde, sei Sache der Selbstverwaltung. Es gebe bereits die Tendenz, sich nochmal in der Sache zusammenzusetzen. Selbst der GKV-Spitzenverband und die weiteren beteiligten Akteure würden sich genau überlegen, ob sie den Klageweg beschreiten wollten oder ob nicht doch in manchen Punkten nachjustiert werden könnte, um eine juristische Auseinandersetzung zu umgehen. Die Schiedsstelle sei mit erheblicher Expertise besetzt und fälle ihre Schiedssprüche auch dementsprechend. Die Materie sei sehr komplex und emotional, sodass das BMG daran arbeite, zu einer Befriedigung beizutragen.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) fragt, wie PStS Tino Sorge die vermittelnde Rolle des BMG sehe.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, er sehe das BMG nicht in der Rolle, die Probleme zu regeln. Dies trage nicht zur Befriedung bei. Es müsse ein Kompromiss erzielt werden, mit der beide Seiten leben könnten und dies werde nur erreicht, wenn jede Seite ihre Argumente vorbringen könne und Zugeständnisse gemacht würden. Es herrsche zwar die Auffassung, dass der GKV-Spitzenverband sich aufgrund seiner Größe und seines Einflusses stets durchsetze, allerdings sei anhand des Kompromissentwurfs erkennbar, dass mit Ausnahme des Deutschen Hebammenverbandes die anderen Verbände den Vorschlag als gangbaren Weg befänden.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) erkundigt sich nach der Rolle des BMG in der Kompromissfindung.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, das BMG eher in einer moderierenden Rolle zu sehen. Er gehe davon aus, dass dies auch erfolgsversprechend sein werde.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sagt, ihre Fraktion teile die

Auffassung, dass die Selbstverwaltung zunächst selbst die Dinge regeln müsse. Grundsätzlich müssten derartige Entscheidungen auch im Kontext politischer Diskussionen getroffen werden. Sofern es eine geeinte Position des Deutschen Bundestages oder des Gesundheitsausschusses in Richtung einer Eins-zu-eins-Betreuung während der wesentlichen Phasen der Geburt gebe und sich Entwicklungen zeigten, die dies konterkarierten, müsse man sich dieser politischen Verantwortung stellen. Das Problem sei nunmehr, dass der zweite Schritt vor dem ersten gegangen werde. Es bestehe Einigkeit hinsichtlich der Eins-zu-eins-Betreuung, allerdings werde dieses Ziel durch die Vergütungsregelungen, wonach die erste Geburt adäquat bezahlt werde, die darauf folgenden jedoch immer weniger, ausgehöhlt. Dadurch bestehe die Gefahr, dass sich die Beleghebammen aufgrund des Kostendrucks aus der Versorgung zurückzögen. Auf Nachfrage beim BMG habe PStS Dr. Georg Kippels geantwortet: „Wenn erforderlich, sollen unverzüglich Verhandlungen zur Weiterentwicklung aufgenommen werden.“ Sie fragt, wie dies konkret aussehe, ob die Evaluation abgewartet werden solle und wie es generell weitergehe.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) stellt klar, dass mit der Evaluation nicht bis 2027 gewartet werden solle und dass bereits auf die schnelle Evaluierung hingewiesen worden sei. Hauptkritikpunkt des Deutschen Hebammenverbandes sei, dass durch die höhere Vergütung der Eins-zu-eins-Betreuung bei der ersten Geburt die wechselweise Betreuung bei der zweiten und dritten Geburt bei der Vergütung nicht kompensiert würden. Der GKV-Spitzenverband behaupte das Gegenteil. PStS Dr. Georg Kippels habe zu Recht darauf hingewiesen, dass in letzter Konsequenz, wenn keine Einigung erzielt werden könne, das BMG aktiv werde.

Abg. **Dr. Kirsten Kappert-Gonthier** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) möchte wissen, wie lange bis zum Vorliegen einer Evaluation gewartet werden solle und was in der Zwischenzeit seitens des BMG unternommen werde. Es bestehe die Sorge, dass die Frist zu lang sei und die Beleghebammen in der Zeit der Versorgung verloren gingen.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, die Schiedsstelle sei mit hochintelligenten Experten besetzt, insbesondere der Vorsitzenden Brigitte Zypries. Im Beschluss vom



Nur zur dienstlichen Verwendung

2. April 2025 sei durch eine Protokollnotiz explizit festgehalten worden, dass die Vertragspartner nach Vorliegen repräsentativer Abrechnungsdaten zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum Inkrafttreten des Vertrages eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe zur Evaluierung der Auswirkungen des angepassten Vergütungssystems einzusetzen hätten. Erforderlichenfalls müssten unverzüglich Verhandlung zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems aufgenommen werden. Es gehe nunmehr darum, dass diese Arbeitsgruppe schnell die Probleme identifiziere. Die Abrechnungsdaten lägen zügig vor, sodass kurzfristig die behaupteten Vergütungseinbußen geprüft werden könnten.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) gibt an, die Vergleichszahlen lägen vor und es müsse nicht über, sondern mit den Beteiligten gesprochen werden. Es drohe eine Mangelversorgung, wenn man die Dinge so weiterlaufen lasse. Die Hebammen wendeten sich nicht grundlos an die Politik, damit diese eingreife. Sie führt aus, nach § 134a SGB V würden die Verträge über die Versorgung von den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Berufsverbände der Hebammen und den Verbänden der von Hebammen geleiteten Einrichtungen geschlossen. Der Vertrag sei hier von Verbänden geschlossen worden, die nur einen sehr kleinen Teil der Hebammen repräsentierten. Sie fragt, ob die Regelung des § 134a SGB V tatsächlich die beabsichtigte Wirkung habe oder ob der GKV-Spitzenverband mit einer relativen kleinen Minderheit der Hebammen einen für alle Hebammen geltenden Vertrag habe schließen können.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) äußert, Beleghebammen machten etwa 20 Prozent aus. Das BMG sei daran interessiert, dass die Hebammenversorgung verbessert werde. Die Intention sei, über eine bessere Vergütung entsprechend die Eins-zu-eins-Betreuung zu präferieren und gleichzeitig zu vermeiden, dass die wechselweise Betreuung anderer Geburten einen finanziellen Nachteil darstelle. Dies müsse untersucht werden, weshalb die Arbeitsgruppe entsprechend dem Beschluss der Schiedsstelle eingesetzt worden sei. Sofern sich die Benachteiligung Dritter aus der Vereinbarung herausstellen sollte, werde darauf reagiert werden müssen. Dies müsse zunächst jedoch durch die Selbstverwaltung geschehen. Eine Festlegung durch die Politik trage nicht zur Befriedung

bei, das habe sich bereits bei den Haftpflichtprämien gezeigt.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) fragt, was die Bundesregierung von der Änderung abhalte, die maßgeblichen Berufsverbände analog zu der Regelung bei der hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V so zu konzentrieren, dass die vertrags-schließenden Verbände mindestens 50 Prozent der Hebammen abbilden müssten.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) weist darauf hin, dass die Schiedsstelle sehr gut besetzt sei und auch die Argumente des Deutschen Hebammenverbandes berücksichtigt habe. Zudem sei der Deutsche Hebammenverband selbst in der Schiedsstelle vertreten und habe dadurch mitgewirkt. Sofern der Klageweg bestritten werde, bestehe bis zum Abschluss des Klageverfahrens die Möglichkeit zur Einigung. Sollte eine gerichtliche Entscheidung getroffen werden, bezweifle er, dass diese zur Befriedung beitragen würde.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) sagt, es sei hilfreich darauf hinzuwirken, dass der Schiedsspruch schnell vorliege. Letztlich stelle sich auch die Frage, wie das BMG im Falle der Mangelversorgung reagieren würde.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) entgegnet, das BMG wolle erst gar nicht, dass eine Mangelversorgung eintrete. Deshalb sei er optimistisch, dass eine Lösung herbeigeführt werde.

Tagesordnungspunkt 3

Bericht der Bundesregierung zum Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und 13 weitere Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Richtlinie zur Anerkennung der Berufsqualifikationen von in Rumänien ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpflegern

Selbstbefassung S-21(14)3

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, die Umsetzung der Richtlinie sei der Diskontinuität anheimgefallen. In der vergangenen Legislaturperiode sei bereits in erster Lesung darüber beraten worden, nun solle die Richtlinie zeitnah umgesetzt werden.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU) fragt, ob es bereits einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung gebe



Nur zur dienstlichen Verwendung

und wie das BMG die Folgen einschätze. Darüber hinaus erkundigt sie sich nach dem Bedarf an rumänischen Pflegekräften für das deutsche Pflegesystem.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) wiederholt, die Richtlinie solle in dieser Legislaturperiode zeitnah umgesetzt werden. Es sei noch offen, in welchem Kontext dies erfolge. Beispielsweise könne die Umsetzung im Zuge der erneuten Einbringung des Pflegeassistenteneinführungsgesetzes erfolgen. Neben Deutschland hätten auch weitere Mitgliedstaaten ein Aufforderungsschreiben der EU-Kommission wegen der fehlenden Umsetzung erhalten. Es bestehe ein erheblicher Bedarf an Pflegefachkräften. Dieser müsse möglichst schnell gedeckt werden.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) beschreibt als Grundproblem, dass viele ausgebildete Pflegekräfte aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen nicht mehr im Beruf seien. Er fragt, wie die Bundesregierung sicherstellen wolle, dass durch die vereinfachte Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen keine Absenkung der fachlichen Standards und damit eine Gefährdung der Patientenversorgung eintrete.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) äußert, dass einerseits aufgrund der fordernden Arbeitsbedingungen im Pflegebereich die Verweildauer bei nur etwa acht Jahren liege, andererseits die Bezahlung mittlerweile aber sehr gut sei und dementsprechend viele Pflegefachkräfte aus der Vollzeit- in die Teilzeitbeschäftigung wechselten. Die Bedingungen müssten nun so optimiert werden, dass die Pflegefachkräfte länger den Beruf ausüben wollten und ausländische Pflegekräfte attrahiert würden. Bei der Berufsanerkennung könne allerdings nicht einfach eine Nivellierung stattfinden, da die Anforderungen im Pflegebereich sehr komplex seien und die Anerkennungsregularien so ausgestaltet werden müssten, dass eine Vergleichbarkeit bestehe und dennoch das Verfahren zügig sei.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) bringt vor, es komme in diesem Zuge durch die Anerkennung unterschiedlicher Berufsabschlüsse zu einer Qualitätsverwässerung. Dies sei für diesen Fachbereich nicht förderlich.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) merkt an, es müsse auch

perspektivisch über die generelle Ausgestaltung der Pflege diskutiert werden. Einerseits gehe es um die optimale Versorgung der Pflegebedürftigen, andererseits müsse über die Möglichkeit nachgedacht werden, dass verfügbare Pflegekräfte mit anderem Qualifikationsprofil gegebenenfalls unterstützende Tätigkeiten wahrnehmen könnten.

Abg. **Birgit Bessin** (AfD) kommt auf die Aussage von PStS Tino Sorge zu sprechen, wonach viele Vollzeitkräfte in Teilzeit wechselten. Aus ihrem Wahlkreis kenne sie es gerade umgekehrt.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es gebe regionale Unterschiede. In einigen Regionen würden viele Pflegefachkräfte aufgrund der besseren Bezahlung in Teilzeit wechseln, genauso würden viele gerne in Vollzeit arbeiten.

Abg. **Birgit Bessin** (AfD) sagt, dies sei ihr bewusst. Die Aussage sei allerdings sehr pauschal gewesen.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erwidert, keine pauschale Aussage getätigt zu haben. Er habe lediglich gesagt, dass es aufgrund der verbesserten Vergütung auch Fälle gebe, in denen der Wechsel zur Teilzeit gewünscht sei. Genauso gebe es auch die gegenteiligen Fälle, da der Bedarf vorhanden sei.

Abg. **Serdar Yüksel** (SPD) äußert, die Bezahlung der Pflegekräfte sei gut, jedoch nicht sehr gut. Viele Pflegekräfte wechselten zwar in Teilzeit, allerdings sei dies nicht auf die bessere Bezahlung zurückzuführen, sondern auf die körperliche Belastung. Ab einem bestimmten Alter seien viele körperlich nicht mehr in der Lage, den Beruf in Vollzeit auszuüben. Er sei selbst unter anderem auf einer Intensivstation Krankenpfleger gewesen und kenne kaum jemanden, der ab 55 Jahren noch in Vollzeit arbeiten könne. Die Verlagerung in Teilzeit zeige vielmehr die Arbeitsbelastung. Bei der Anerkennung der rumänischen Pflegediplome sei das Problem, dass es sich um Pflegekräfte handele, die ein Aufstiegs- bzw. Fortbildungsprogramm absolviert hätten. Hinzu käme die ethische Problematik, dass Deutschland nicht genügend Pflegekräfte ausbilde und deswegen Pflegekräfte aus dem Ausland anwerbe, die dort ebenfalls gebraucht würden. Dieser Magneteffekt führe weltweit zu großen Verwerfungen. Es müssten weiterhin genügend Ausbildungsplätze geschaffen und die Attraktivierung des Berufes vorangetrieben werden. Er fragt, wie in Zukunft



Nur zur dienstlichen Verwendung

die Beschleunigung der Anerkennungsverfahren sichergestellt werden solle. Zudem sei Deutschland am 22. Mai 2025 von der EU-Kommission zur Umsetzung der entsprechenden Richtlinie aufgefordert worden und habe dafür zwei Monate Zeit, sodass er frage, ob dies zeitlich überhaupt möglich und ob eine Anpassung des Pflegeberufgesetzes erforderlich sei.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, die EU-Kommission könne eine Stellungnahme übermitteln, wenn der zwei-monatigen Frist nicht nachgekommen werde. Sofern die Richtlinie dann nicht umgesetzt worden sei, könnte als nächste Eskalationsstufe ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. Dazu werde es jedoch nicht kommen, da der zeitnahe Umsetzung nichts entgegenstehe. Bezüglich der ethischen Problematik, dass man im Ausland benötigte Pflegekräfte nach Deutschland hole, beteuert er, dass diese auch vom BMG gesehen werde. Allerdings handele es sich dabei nicht um eine weltweite, sondern nach Ländern differenzierte Situation. Auch die Anerkennungsverfahren stellten eine große Schwierigkeit dar, da sie sehr lange dauerten und in den Bundesländern teilweise von Mittelbehörden mit nur zwei bis drei zuständigen Personen bearbeitet würden. Das Verfahren müsse daher nicht nur schneller, sondern auch flexibler werden, ohne dass es zu einer Nivellierung komme.

Abg. **Simone Fischer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) möchte angesichts der notwendigen Prozesse im Gesetzgebungsverfahren wissen, welche konkreten Schritte bereits zur Umsetzung der Richtlinie unternommen worden seien und ob eine Anpassung im Pflegeassistenzeinführungsgesetz angestrebt werde. Außerdem erkundigt sie sich, ob die ursprünglich im § 42 Pflegeassistenzeinführungsgesetz vorgesehene Anpassung als ausreichend für die Anforderungen der EU-Kommission erachtet werde oder ob weitere Änderungen notwendig seien. Abschließend fragt sie, wie viele rumänische Pflegekräfte derzeit in Deutschland tätig seien, deren Anerkennungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, auf einige Fragen keine Antwort liefern zu können. Die Anzahl der

rumänischen Pflegefachkräfte im Anerkennungsverfahren werde nachgeliefert.¹ Die Umsetzung der Richtlinie beginne nicht bei null, da das Gesetz in der vergangenen Legislaturperiode bereits in erster Lesung beraten worden sei und die Kolleginnen und Kollegen im BMG bereits damit befasst seien. Gegebenenfalls könne die Umsetzung an einem Trägergesetz angedockt werden. Im Rahmen der Prioritätensetzung gehe es nun darum, welche Vorhaben noch vor der Sommerpause eingebracht werden könnten.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) wundert sich, wie die Entschädigung von Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretären eingeordnet werde, wenn bereits die Bezahlung der Pflegeberufe als „sehr gut“ beschrieben werde. Außerdem sagt er, in den vergangenen zwei Jahren sei die Quote der Teilzeitbeschäftigten im Pflegebereich von 44 auf 50 Prozent gestiegen. Eine denkbare Lösung sei die Einführung der Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich. Wenn die körperliche Belastung so hoch sei – wie auch von der Fraktion der SPD dargestellt –, dass die Ausübung in Vollzeit nicht möglich sei, müsse über eine andere Form der Vollzeit nachgedacht werden. In Bezug auf die Umsetzung der Richtlinie sei er verwundert über die Aufsetzung auf der Tagesordnung. In der vergangenen Legislaturperiode habe es zwar eine erste Lesung gegeben, die damalige Oppositionsfraktion CDU/CSU sei jedoch dagegen gewesen. Er erkundigt sich nach den damaligen Beweggründen und fragt, ob weitere Änderungen und Anpassungen angestrebt würden.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, die Ablehnung der Fraktion der CDU/CSU in der letzten Wahlperiode sei darin begründet gewesen, dass das Pflegekompetenzgesetz eine Vielzahl verschiedener Regelungen umfasse und an einigen Stellen noch Bedarf zur Nachjustierung gesehen worden sei. Dies sei im parlamentarischen Verfahren üblich und es sei eben kein Kompromiss gefunden worden, sodass das Gesetz der Diskontinuität anheimgefallen sei. Das parlamentarische Verfahren benötige einen gewissen Vorlauf und das BMG bereite das Gesetz gründlich vor.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) hakt nach, ob es Änderungen geben werde und wo diese vorgesehen

¹ Antwort lag bei Veröffentlichung des Protokolls noch nicht vor.



Nur zur dienstlichen Verwendung

seien.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, es würden an einigen Stellen Änderungen vorgenommen und sodann ein sehr guter Gesetzentwurf eingebracht. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit würden die Regelungen möglicherweise beim Pflegeassistenzeinführungsgesetz angedockt. Ebenso sei ein Omnibusgesetz eine Option.

Tagesordnungspunkt 4

Bericht der Bundesregierung über die aktuelle Finanzsituation der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Sozialen Pflegeversicherung sowie über die geplanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzierung

Selbstbefassung S-21(14)4

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) gibt an, die Situation der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und Sozialen Pflegeversicherung (SPV) nicht schönreden zu wollen. Im Wege gesellschaftlich gewünschter Leistungsausweitungen sei es in den letzten Jahren zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen. Die Debatte über strukturelle Änderungen in der GKV, der SPV und in anderen sozialen Sicherungssystemen sei noch nicht so, wie sie gesellschaftlich sein sollte. Im Jahr 2024 habe es bei der GKV ein Defizit von 10 Milliarden Euro gegeben, davon 6 Milliarden bei den Krankenkassen und 4 Milliarden beim Gesundheitsfonds. Durch die einmalige Liquiditätshilfe Mitte Mai in Höhe von 800 Millionen Euro durch Vorziehen der Dezemberrate könnten Defizite ausgeglichen werden. Die Zusatzbeiträge seien zum Jahresbeginn 2025 stark gestiegen, was keine schöne Entwicklung auch im Hinblick auf die steuerliche und die Beitragsbelastung darstelle. Allerdings seien die Entwicklungen auch dem Umstand geschuldet, dass die Ausgaben stärker stiegen als die Einnahmen und Zusatzbeiträge. Denkbar seien zwar Steuererhöhungen oder höhere Zusatzbeiträge, dies sei jedoch nicht Sinn der Sache. Es brauche in erster Linie strukturelle Änderungen, aber auch zusätzliche Haushaltsmittel. Die SPV habe im Jahr 2024 ein Defizit von 1,5 Milliarden Euro verzeichnet, für 2025 gehe man momentan von ca. 0,5 Milliarden Euro aus. Für das Jahr 2026 werde mit einem weiteren deutlichen Defizit von 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Er würde sich freuen, wenn

künftig in der Diskussion mehr Transparenz bezüglich der Mittel herrsche. Beispielsweise fehlten bei den Abführungen für die Bürgergeldbezieher in den Gesundheitsfonds mittlerweile etwa 10 Milliarden Euro. Im Bereich der SPV sei noch zu klären, was mit den Geldern sei, die für Corona-Maßnahmen aufgewendet worden seien und ca. 5,2 Milliarden Euro betrügen. Es müsse sich darüber verständigt werden, wie mit gesamtgesellschaftlichen Aufwendungen umgegangen werden solle und wie das System ausgestaltet werde, beispielsweise mit den Sozialversicherungsbeiträgen pflegender Angehöriger. Dafür bedürfe es allerdings auch Transparenz darüber, woher die Gelder kommen sollten und wie sie verwendet werden sollten. Das bedeute eine Diskussion über eine höhere Eigenverantwortung, über unterschiedliche Säulenmodelle, über die Umleitung von Finanzkapazitäten oder über die Frage der Priorisierung. Gesundheitsvorsorge sei Daseinsvorsorge, dies müsse explizit in der gesellschaftlichen Debatte stärker kommuniziert werden. Es müsse deutlich werden, dass es sich nicht nur um einen Kosten-, sondern auch um einen Wertschöpfungsfaktor handele. Es gebe in diesem Bereich erhebliche Innovationen.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) stellt klar, es gebe an vielen Stellen kein Erkenntnisproblem, sondern es müsse vielmehr gehandelt werden. Es nütze nichts, Geld in ein krankes System fließen zu lassen. Es brauche ein Umdenken und neue Strukturen. Sie frage, wie das BMG plane, die finanziellen Möglichkeiten des Sondervermögens für die Finanzierung der GKV und SPV zu nutzen.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erläutert, das BMG plane im Rahmen des Sondervermögens eine Stabilisierung der Systeme, um damit die für die Neustrukturierung erforderliche Zeit zu gewinnen. Selbst bei zeitnahe Umbauen des Systems bedeute dies nicht, dass sich sofort Einsparpotenziale und Kompensationsmöglichkeiten ergäben. Der Gesundheitsbereich sei daher mit der Krankenhausversorgung und der Resilienz im Verteidigungsfall auch im Sondervermögen vorgesehen. In den Haushaltsberatungen müsse nun sichergestellt werden, dass die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung gestellt würden.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) kommt auf das Defizit von ca. 10 Milliarden Euro zu sprechen, das bei den Beiträgen der Bürgergeldempfänger fehle. Die Bundesministerin habe letzte Woche gesagt, dass



Nur zur dienstlichen Verwendung

die Beiträge der Jobcenter nicht zur Deckung der Gesundheitskosten reichten und eine Schieflage bestehe. Er fragt, wann hier etwas geändert werde.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) äußert, die Debatte werde bereits seit zwei Legislaturperioden geführt und stelle immer eine Problematik in den Haushaltsberatungen dar. Die jeweiligen Bundesministerien hätten ihre Forderungen. Am Ende seien hier die Beitragszahler benachteiligt, weil sie die Ausgaben kompensieren müssten. Es ergebe keinen Sinn, über strukturelle Änderungen nachzudenken, wenn am Ende das durch die Änderungen Ersparte gegebenenfalls durch versicherungsfremde Leistungen wieder dem System entzogen werde. Das sei eine Grundsatzfrage, die geklärt werden müsse und die in mehreren Koalitionsverhandlungen Gegenstand gewesen sei. Wie Abg. Simone Borchardt bereits gesagt habe, bestehe kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit. Er sei hoffnungsvoll, dass es Fortschritte in den Haushaltsberatungen geben werde. Es brauche jedoch Zeit, um die Strukturen zu verändern. Darüber hinaus betont er, dass das System von der Akzeptanz der Menschen lebe, die in dieses einzahlten.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) fragt, ob das BMG sich im Rahmen der Haushaltsberatungen dafür einsetzen werde, dass der Beitrag von monatlich 109 Euro für Bürgergeldempfänger erhöht werde.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht dies. Haushaltsberatungen seien jedoch dynamisch und das BMG sei ein sehr komplexes Ministerium, sodass es darum gehe, über bestimmte Kompensationen Druck aus dem System zu nehmen. Es sei allerdings schwierig vorherzusagen, wie die Haushaltsberatungen ausgehen würden.

Abg. **Martin Sichert** (AfD) kommt auf die 500 Milliarden Euro Sondervermögen zu sprechen. In seinem Wahlkreis drohten aktuell zwei Krankenhäuser zu schließen, unter anderem die einzige Geburtstation im Landkreis. Gleichzeitig gebe es Millioneninvestitionen etwa in Solarfelder und Windanlagen. Es sei daher schwer den Menschen zu vermitteln, weshalb lebensnotwendige Infrastrukturen wegfielen. Er möchte wissen, wie viel von den 500 Milliarden Euro Sondervermögen das BMG für Investitionen in den Gesundheitsbereich vorsehe.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für

Gesundheit (BMG)) gibt an, die Anmeldungen für die Ausgaben des Sondervermögens und die Verteilungen befänden sich derzeit im Fluss. Es gebe bestimmte Festlegungen, welche Anteile für welche Bereiche ausgegeben werden sollten; darunter falle auch der Gesundheitsbereich. Das Verfahren sei dynamisch und bestimmte Beträge würden für Projekte vorgesehen. Auch die Krankenhausreform werde beispielsweise noch nachjustiert. Insgesamt müssten die zur Verfügung gestellten Mittel sinnvoll eingesetzt werden.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) stimmt ebenfalls zu, dass kein Erkenntnis-, sondern ein Handlungsdefizit bestehe. Er möchte wissen, ob das BMG eine regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses für erforderlich halte, um eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage sicherzustellen.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) zeigt sich positiv gegenüber regelhaften Dynamisierungen. Aufgrund unvorhersehbarer Dinge, wie zum Beispiel Ukraine-Krieg und Inflation, seien die Kosten in vielen Bereichen explodiert. Es müsse nun Druck aus dem System genommen und über gewisse Dynamisierungen gesprochen werden. Im Idealfall werde es zu einer Mischlösung kommen, also einer teilweisen Dynamisierung und darüber hinaus weiteren Verhandlungen über Kompensationen.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) sagt, seit Anfang des Jahres müssten die Versicherten durch einen erhöhten Zusatzbeitrag von über 2,5 Prozent erhebliche Mehrbelastungen tragen. Er möchte wissen, welche kurzfristigen Maßnahmen das BMG vor dem Hintergrund, dass die Kommission erst 2027 Ergebnisse vorweisen werde, zur Entlastung der Versicherten plane.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, im Idealfall lege die Kommission früher als 2027 Lösungsvorschläge vor. Es bestehe zwar kein Erkenntnisdefizit, wichtig sei aber die Akzeptanz. Insofern gehe er davon aus, dass die Kommission gute Vorschläge unterbreiten werde. Es brauche zunächst eine kurzfristige Entlastung, mittel- und langfristig sodann durch Ankurbelung der Konjunktur mehr Beitragszahler mit gutem Einkommen.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) gibt an, mit der Kommission zur Pflege habe die Bundesregierung einen wichtigen Prozess angestoßen, um die



Nur zur dienstlichen Verwendung

Pflegeversicherung dauerhaft tragfähig zu gestalten. Er fragt, ob die Kommission auch prüfe, ob bestimmte gesellschaftliche Leistungen, beispielsweise für pflegende Angehörige, künftig verlässlich steuerfinanziert werden könnten, um die Pflegeversicherung nachhaltig zu entlasten und den Beitragssatz stabil zu halten.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht dies.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) thematisiert ebenfalls die einzusetzende Kommission, die bis 2027 Vorschläge zur Stabilisierung der Beiträge erarbeiten solle. Angesichts der Länge parlamentarischer Vorgänge und dem Beratungserfordernis innerhalb der Koalition sei frühestens 2029 oder 2030 mit Auswirkungen zu rechnen. Sie fragt, ob PSSt Tino Sorge dieser zeitlichen Prognose zustimme, ob die Kommission schon eingesetzt worden sei und wer dieser angehören werde.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) teilt diese Einschätzung nicht. Die Kommission müsse nun schnell die Arbeit aufnehmen. Für die Besetzung werde ein Vorschlag unterbreitet, die auch unter Beteiligung des Parlaments erarbeitet werden solle. Es brauche allerdings auch keine Kommission mit vielen Mitgliedern, die am Ende nicht zu einem Ergebnis gelange. Vielmehr müsse schnell ein Ergebnis erzielt werden, im Optimalfall vor 2027. Bei der Umsetzung freue man sich über konstruktive Unterstützung und es werde parallel daran gearbeitet, wie das System kurzfristig stabilisiert werden könne. Es sei also eine Mischung aus kurzfristiger Stabilisierung, Zeitverschaffung, strukturellen Ideen und entsprechender Umsetzung. Er gebe zu, dass der Gesamtprozess noch nicht 2029 abgeschlossen sein werde und dann das Problem gelöst sei. Dafür brauche es noch mehr Zeit.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, in dem geleakten Koalitionsvertrag seien konkrete Vorschläge zur kurzfristigen Stabilisierung enthalten gewesen, zum Beispiel zur Zahlung der kostendeckenden Beiträge für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger oder die Rückzahlung der Corona-Ausgaben bei der Pflegeversicherung. Sie fragt, warum diese im endgültigen Koalitionsvertrag nicht mehr enthalten seien und wo es Uneinigkeiten hinsichtlich der Sofortmaßnahmen gegeben habe.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) begründet dies damit, dass der Kommission, die inhaltlich arbeiten solle, nicht das Ergebnis vorgesagt werden sollte. Er gehe davon aus, dass die Vorschläge von der Kommission berücksichtigt würden.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) entgegnet, es handele sich dann nicht mehr um Sofortmaßnahmen. Sie fragt, ob bereits Potenziale hätten identifiziert werden können, um die stetig steigenden Ausgaben in den Griff zu bekommen. Es habe kürzlich seitens des Sachverständigenrates dazu konkrete Vorschläge gegeben.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erläutert, zur Stabilisierung werde mehrgleisig gearbeitet. Im Bereich der Sofortmaßnahmen seien beispielsweise kurzfristige Mittelbedarfe beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) angemeldet. Parallel laufe die Debatte zu strukturellen Änderungen, die einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Die Vorschläge des Sachverständigenrates seien schon in den letzten Jahren sehr gut gewesen, die Umsetzbarkeit werde sich zeigen.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) führt an, BMn Nina Warken habe kürzlich in einem Interview – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Prof. Dr. Karl Lauterbach – Leistungskürzungen nicht gänzlich ausgeschlossen. Er möchte wissen, ob die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode Leistungskürzungen ausschließe.

PSSt **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, man müsse sich über strukturelle Fragen verständigen und einige Aspekte modifizieren. Zu der Frage, ob bestimmte Modifikationen Leistungskürzungen darstellten, gebe es unterschiedliche Bewertungen. Beispielsweise sei im Bereich der Patientensteuerung deutlich, dass gewisse medizinische Leistungen sinnvoller genutzt werden könnten. Es könne nicht jede Modifizierung per se als Leistungskürzung betrachtet werden, vielmehr müsse sich darüber verständigt werden, wie man eine gute Versorgung nachhaltig und langfristig aufrechterhalten könne.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) gibt an, für die Gesellschaft sei es ein wesentlicher Unterschied, wenn die Gesundheitsministerin Leistungskürzungen ausschließe oder sage, es würden Dinge optimiert und gegebenenfalls Leistungskürzungen vorgenommen. Er habe heute aus der Zeitung erfahren,



Nur zur dienstlichen Verwendung

dass BM Lars Klingbeil 16 Milliarden Euro für den Gesundheitsbereich versprochen habe, allerdings nur einmalig. Er möchte wissen, ob dieser Betrag schon für bestimmte Punkte verplant worden sei.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) erklärt, BMn Nina Warken habe nicht gesagt, dass es Leistungskürzungen geben werde. Sie habe vielmehr geäußert, dass im System strukturelle Reformen herbeigeführt werden müssten. Die konkrete Ausgestaltung werde dann im Parlament besprochen. Die Frage der Pauschalabgeltung sei aufgrund der Komplexität des Bereiches sehr schwierig, da Einmalzahlungen nicht ausreichen. Es gebe eine gewisse Dynamik durch wiederkehrende Leistungen. Aktuell befinde man sich noch in Beratungen mit dem BMF, die genannten 16 Milliarden Euro wolle er daher nicht kommentieren.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) spricht an, der ehemalige Gesundheitsminister Bayerns, Klaus Holetschek, habe attestiert, die Zeitplanung bis 2027 sei zu spät. Er erkundigt sich, ob nicht doch früher Ergebnisse vorgelegt werden könnten.

PStS **Tino Sorge** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) wiederholt, es sei geplant, schneller als 2027 zu Ergebnissen zu gelangen.

Tagesordnungspunkt 5

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Deutscher Fortschrittsbericht 2025

BT-Drucksache 21/62

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung durch die Bundesregierung auf BT-Drucksache 21/62 einvernehmlich zur Kenntnis.

Schluss der Sitzung: 11:24 Uhr

gez.

Dr. Tanja Machalet, MdB

Vorsitzende